

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	冠狀動脈氣球擴張術 Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty ; PTCA				
編號	A31000-Q03-W-B06	制定者	CCU 林炳蓁	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 3.9 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解冠狀動脈氣球擴張術的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與護理措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

心導管檢查是一種用來評估心臟功能壓力及瓣膜疾病、血管病變的診斷過程，它以各種不同成形的導管，經由導引線及 X 光透視之導引，將導管從動脈鞘管進入，經腹主動脈、主動脈弓至主動脈根部，利用 X 光不透光之顯影劑幫助將導管前端置於冠狀動脈開口，注入顯影劑利用 X 光攝影獲得各種不同角度之動態影像，以其顯示粥狀硬化阻塞的病灶位置、狹窄程度、栓塞範圍及側枝循環等，或先天性的生理解剖異常。

（二）症狀

當有瓣膜性心臟疾病、先天性心臟病、冠狀動脈疾病之治療。

（三）常見檢查

1. 右心導管檢查：乃由股靜脈置入導管，沿著靜脈血管壁順行而上，進入下腔靜脈，再經過右心房、三尖瓣，到達右心室，此時心導管還可進一步伸入肺動脈來測量肺微血管楔壓。
2. 左心導管檢查：將導管經由股動脈，順著腹主動脈、胸主動脈而上，到達主動

主題名稱	冠狀動脈氣球擴張術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B06	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/5

脈弓及冠狀動脈開口處，可進行冠狀動脈攝影。

(四) 常見治療

- 1.經皮冠狀動脈介入治療術(percutaneous coronary intervention, PCI)。
- 2.冠狀動脈支架置放術(stent)。

(五) 護理問題

- 1.低心輸出量/與冠狀動脈阻塞有關。
- 2.尋求（特定的）健康協助，與缺乏冠狀動脈氣球擴張術相關知識有關。

(六) 護理措施

- 1.低心輸出量/與冠狀動脈阻塞有關
 - (1)注意呼吸速率和節律，給予氧氣並記錄使用效果。
 - (2)監測生命徵象及意識型態。
 - (3)裝置生理監視器監測心跳速率和節律。
 - (4)評估皮膚溫度和顏色，觀察周邊水腫，每日量體重並記錄。
 - (5)依醫囑給予藥物並記錄使用效果。
 - (6)依醫囑控制液體攝入量。
 - (7)每班聽診雙足背脈搏並記錄。
- 2.尋求（特定的）健康協助，與缺乏冠狀動脈氣球撐開術相關知識有關
 - (1)告知含碘可能會引起過敏，熱原反應宜注射 Vena。
 - (2)術前進行皮膚準備（通常為雙側鼠蹊部）。
 - (3)術前至少 4 小時禁食和飲料，藥物則需按醫囑準備。
 - (4)按醫囑於檢查前 30 分鐘給予鎮靜劑使病人鬆弛。
 - (5)測量病人身高、體重。
 - (6)檢查完後 1 小時，如無不適，可先喝水，又無不適即可進食。
 - (7)解小便後，鼓勵病人多喝水以利顯影劑排出。
 - (8)告知傷口會以 3 公斤砂袋加壓 6 小時，插入導管之肢體宜保持平直 6-8 小時，並平躺 6-8 小時才可改變姿勢，但仍需臥床休息 24 小時。

主題名稱	冠狀動脈氣球擴張術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B06	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/5

(9)臥床期間如要解尿，協助病人在床上使用便盆或尿壺。

(10)檢查完後，應注意生命徵象變化，並觀察傷口有無出血、感染情形。

(11)每 15 分鐘檢查一次，共四次；每 30 分鐘檢查一次，共四兩次；每一小時一次共兩次，檢查兩側肢體膚色、溫度、脈搏強度。

(七) 衛教指導

給予「放置心臟血管支架之居家自我照顧注意事項」、「心導管術後注意事項」之衛教。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 謝春蘭、高碧霞、蔡文惠、謝玉娟、吳玉玲、歐育珊等(2019)・急重症護理學，永大。
- (二) 莊孟蓉、戴志楠 (2025)・以精實手法導入心導管檢查照護流程優化之成效初探—台灣南部某醫學中心為例・醫院雜誌，58(1)，1-13。
- (三) 楊寧綺、黃佩珍、沈美麗、郭惠婷、章正俐、吳貞鑒、柯雅婷 (2021)・探討運用擬真情境教學提升心導管檢查術後肢體評估與處置之學習成效・台灣擬真醫學教育期刊，8(2)，16-30。

七、附件

主題名稱	冠狀動脈氣球擴張術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B06	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/5

(略)

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定。	98 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	修改目的的錯別字。	100 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	1.醫護部改護理部。 2.護理措施部份內容修辭。	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.31	3.1	說明內容部份修辭。	102 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.2	更新第六項參考資料。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.3	1. 新增參考文獻資料於內文中。 2. 第六項參考資料增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日 護理長會議通過。
108.09.23	3.5	1. 第三項第六目之 2(8) 3 公斤沙袋加壓時間改為 6 小時。	108 年 09 月 11 日 護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議

主題名稱	冠狀動脈氣球擴張術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B06	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/5

修正日期	版本	修正說明	備註
		2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	通過公布。
109.08.06	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.19	3.6	第三項第四目之 1 治療名稱修訂。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過；110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	3.7	1. NANDA 護理診斷更新為護理問題。 2. 新增第六項參考資料。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過；111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.11.21	3.8	1. 第三項第三目刪除(貴要靜脈)及(臂動脈)。 2. 第三項第五、六目刪除護理問題：易受傷害，與注射抗凝劑、出血有關。 3. 第三項第五、六目新增護理問題：低心出量/與冠狀動脈阻塞有關。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過；112 年 11 月 08 日護理長會議通過；112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.10.15	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.01.06	3.9	第六項參考資料修訂。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。